



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : وفاء فرج محمد ~
 المحافظة : الجيزة
 العمر (تاريخ الميلاد) : 24-10-1961
 رقم البطاقة : 26110240102186
 رقم التليفون : 01021821007
 العنوان : -----
 تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026
 المهنة : بائع خضار

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
 الإخصائي الاجتماعي
 التوقيع: (-----)
 المقر بما فيه
 التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
 نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
 خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج كيماوي خط ثاني لورم منتشر
 عقار (Vinorelbine oral) [14154]
 قسم العلاج :
 الاورام
 التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
 الوظيفة :
 التوقيع :
 الاسم : د/ندى حسن
 الوظيفة :
 التوقيع :
 الاسم : د/نرمين رمضان
 الوظيفة :
 التوقيع :
 أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
 وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
 كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
 تعتمد صحة البيانات المرفقة
 رئيس اللجنة ومدير
 المستشفى.
 تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
 خطة العلاج :
 المستشفى :
 قسم :
 جهة العلاج :
 نفقات :
 ملاحظات :

ختم
 شعار الجمهورية

مدير عام
 مديرية الشؤون الصحية

رئيس
 المجلس الطبي المتخصص

--

Name: وفاء فرج محمد ~ National ID: 26110240102186	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Oral vinorelbine chemotherapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Patient Name: Wafaa Farag Mohamed Anani	Date : 22/11/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 64 Year(s)
Medical ID: 4053/2023	Pat. ID: 80359

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS

REVEALED:

known case of Left CBS. Compared to the last CT examination dated 17/2/2025 (hard copy with no DICOM series), the current study revealed

I- CHEST:

- No significant time interval changes of bilateral variable sized scattered lune nodules/masses, the largest is seen in middle lung lobe measures about 1.4 cm
- No significant time interval changes of bilateral apical fine reticulations and scattered atelectatic bands likely post radiation sequel.
- Minimal right pleural thickening with few pleural nodules are noted
- Multiple enlarged mediastinal lymph node.
- No pleural or pericardial collection.
- The heart is seen enlarged in size.
- Still noted small bilateral fibroelastoma dorsi being evident on right side.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No dilated biliary radicles. Right hepatic focal lesion segment VIII measures about 1 cm with contrast filling in delayed phase likely hemangioma.
- The gall bladder is well distended, average wall thickness with no stones.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- No significant time interval changes of bilateral suprarenal glands well defined iso to hypodense nodule measures on right side about 2.1x1.4cm and on left side about 1.1x0.8cm.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, , aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- Subcentimeteric abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

Name	Mrs. Wafaa' Farag Mohamed Anany		
Ref. By Prof. Dr.	Emad Mohsen Barsoum	Date	19/7/2026
ID	1111022637	Acc. No.	291352924

¹⁸F-FDG PET/CT Scan

Indication of the study: Status follow-up study for a case with previous history of managed breast malignancy. No available pathological data. Compared to 2.2026 study.

Total body PET scan was done 40 minutes after IV administration of 300 MBq of ¹⁸F-FDG.

CT scanning was performed simultaneously without IV contrast material injection.

Semi-quantitative analysis would be done for selected ROIs & the normal threshold would be the normal blood pool liver SUV max. < 2.3

Head & Neck:

- Normal physiological biodistribution over scanned portion of the brain.
(N.B; not all brain metastatic lesions could be detected on ¹⁸-FDG PET/CT due to physiologic uptake in brain. MRI brain is suggested in cases of clinical suspicion).
- Normal naso-/oro-pharynx, larynx, thyroid and salivary glands.
- No enlarged FDG hypermetabolic cervical L.Ns seen.

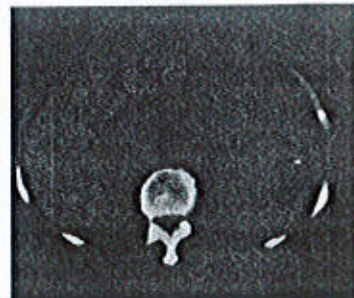
Torso:

Thorax:

- *Low activity management bed reticulations.*
- *No focal breast active masses.*
- *No enlarged FDG hypermetabolic mammary related lymph nodes.*
- *For mammographic correlation.*
- *Bilateral variable sized metabolically active pulmonary / right pleural nodules, largest measuring ± 1.5 cm versus 2 cm, eliciting SUVmax. 4.5 versus SUVmax. 6.5.*
- *Regressive course of the active bilateral hilar and mediastinal (all groups) lymph nodes, largest about 1.5 cm versus 1.8 cm of SUVmax. 5 versus SUVmax. 8.5.*
- *No sizable effusion in today's study.*

Abdomen & Pelvis:

- *Average size of the liver with multiple active focal lesions, largest about 1.8 cm versus 3 cm of SUVmax. 2.5 versus SUVmax. 9. For dynamic MRI study assessment.*
- *Metabolically active porta-hepatis lymph node measuring about 2.8 cm of SUVmax. 2.5 versus SUVmax. 13 (regressive course).*
- No biliary tree dilatation.
- Average size of the spleen with no focal active lesions.
- Normal appearance of pancreas (no sizable active masses), adrenals and pelvic organs.
- Congested mesentery with strandy reticulations.
- Normal physiological biodistribution over the bowel (non-uniform bowel uptake with no sizable masses) & urinary tracts.



Name	Mrs. Wafaa' Farag Mohamed Anany		
Ref. By Prof. Dr.	Emad Mohsen Barsoum	Date	19/7/2026
ID	1111022637	Acc. No.	291352924

Surveyed skeleton:

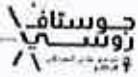
- *Faint marrow uptake of SUVmax. 2.8 versus SUVmax. 3.5 recorded at D10.*
- *Regressive course of sacral activity and presacral sheets of SUVmax. 3 versus SUVmax. 6 with underlying lucency at right aspect of the right sacral aspect.*
- *Resolution of the active tiny D2 and D11 foci of SUVmax. up to 3.5.*
- Scattered sclerotic non-metabolically active foci of the spine and pelvic bones (mostly degenerative changes).

Opinion:

- Regressive course since last study.
- No newly developed active neoplastic masses.

Best Regards;

Dr. Islam Aboulwafa, MD



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية



02/12/2026

MDT FORM

Name:	Wafaa Farag Mohamed .	MRN:	609
Age:	64 Y	ID:	4053/2023
Menopausal Sta	post	Phone:	01156559976
NRS SCORE:	PS1	Marital Status:	married
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:		Reason Of MDT:	

Clinical Data:

BX: IDC

ER: 4/8 **PR:** 7/8 **HER2:** -ve **KI67:**

R

L

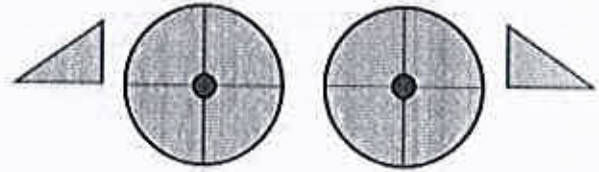
Sonomammography:**Mets Workup:****History:**

The patient underwent breast-conserving surgery (BCS) followed by adjuvant chemotherapy and radiotherapy. kept on hormonal for 3 years >>> mets >>>> She was subsequently started on Palbociclib , Fulvestrant and received 6 cycles.

04/2025 >> newly developed bony lesions >>> shifter affinitor , aromazine from 05/2025 >> received 6 cycles >>> mixed response >>> shifted to

Recommendations:**MDT Outcome & Plan**

for rebiopsy from HFL
Meanwhile start Navelbine



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ هائل عزت					

Name :	Mrs / وفاء فرج محمد عناني	Acc No :	2156044
Branch :	فيصل	Age :	64 Y
Referred By :	ا.د / عماد برسوم	Sex :	F
		Registration Date :	09-12-2025 13:56
		Reporting Date :	10-12-2025 13:27

Tumour Markers Report

<u>Test</u>	<u>Result</u>	<u>Unit</u>	<u>Reference Range</u>
CarcinoEmbryonic Antigen (CEA)	40.80	ng/mL	non smoker up to 5 smoker up to 7
CA 15.3	>500.00	U/mL	Up to 31.00

Approved by

Dr. Amr Yusuf

ic : وفاة لرج محمد عفاى

Age : 61

Pathology No : 11633/23

Hospital No. 17732/23

a: Block review of pleural thickening biopsy, h/o of treated breast cancer diag & u
: مريض علاه خارجيه وحده جراحه - ب Referring Dr. :

Electronically Authorized by: RIHAM GABR

traffin block & five slides: Two H&E & Three referred immunostained slides labeled by
in Arabic and coded 773305.

ic :

d material is infiltrated by an invasive carcinoma formed of irregular solid groups of
ithelial cells with focal ductal differentiation, and having hyperchromatic nuclei with modest
Anaplasia and mitosis are moderate. Surrounding stroma shows moderate fibrosis . Referred
ed slides show tumor cells positive for GATA3, & ER is positive with strong nuclear staining in
r cells (Score 8/8). Her2 is negative (score 0). Regarding provided clinical history of breast
asitivity of GATA-3 & ER, Picture is consistent with metastatic invasive carcinoma, suggestive
in. Recommended for mammographic radiological results correlation to exclude contralateral
iancy primary.

Pleura, Referred slide: Metastatic invasive carcinoma

Malignant Tumor, Metastatic at Initial